

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAYANAN ANESTESI DI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO		
	No. Dokumen 962.10/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis anestesi dalam kerja sama tim meliputi penilaian pra operatif (pra anestesi dan sedasi), intra anestesi dan pasca anestesi serta pelayanan lain sesuai bidang anestesiologi antara lain terapi intensive, gawat darurat dan penatalaksanaan nyeri.	
Tujuan	Sebagai dasar dan acuan pelayanan Anestesi dan Sedasi di RS Prima Husada Sukorejo yang memenuhi aspek mutu dan keselamatan pasien.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi	
Prosedur	Masa Pra Anastesi / Pembedahan 1. Evaluasi pra anestesi / pra bedah dikerjakan segera / dalam periode 24 jam sebelum tindakan anestesi / pembedahan. 2. Terapi atau pemeriksaan yang diperlukan dapat dilaksanakan hendaknya diberikan waktu yang cukup untuk evaluasi tersebut. 3. Evaluasi Pra Anastesi mencakup: a. Identifikasi pasien. b. Pemahaman prosedur bedah / medik yang akan dilakukan. c. Riwayat medis, pemeriksaan klinis rutin dari pasien dan pemeriksaan khusus. d. Konsultasi dengan dokter spesialis lain bila diperlukan. e. Memberikan penjelasan tentang tindakan anestesi dan memastikan <i>informed consent</i>. f. Penganturan dan pemeriksaan lain yang diperlukan untuk mencapai kondisi pasien yang optimal misalnya terapi cairan, tranfusi, terapi napas, dll. 4. Perawatan pra anestesi dimulai saat pasien berada di ruang perawatan, atau dapat juga dimulai pada saat pasien diserahkan di ruang operasi dan berakhir saat pasien dipindahkan ke meja operasi. 5. Dalam menerima pasien yang menjalani tindakan anestesi, perawat anestesi wajib memeriksa kembali data dan persiapan anestesi, diantaranya :	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO	PELAYANAN ANESTESI DI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO		
	No. Dokumen 962.10/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 3
	- Memeriksa identitas pasien dan keadaan umum pasien. - Kelengkapan status / rekam medik pasien. - Surat persetujuan operasi dari pasien dan keluarga. - Data laboratorium, rontgen, EKG dan lain-lain. - Gigi palsu, lensa kontak, perhiasan, cat kuku, lipstick dan lain-lain. - Menggantikan baju pasien. - Membantu pasien untuk mengosongkan kandung kemih. - Mencatat timbang terima pasien. 6. Perawat anestesi juga bertugas memberikan premedikasi berdasarkan intruksi tertulis dari dokter anestesi. Masa Anestesi / Pembedahan - Tindakan anestesi harus dikerjakan dalam kerja sama tim. Seorang dokter spesialis anestesi harus didampingi perawat terlatih. Keamanan pasien selama anestesi dan pembedahan memerlukan pemantauan fungsi <i>vital sign</i> yang terus menerus / berkala yang dicatat dengan baik pada RM minimal tiap 5 menit sekali. - Prosedur pembedahan dapat diubah jika kondisi pasien mengarah pada keadaan yang membahayakan jiwa. - Sarana pengaturan dosis obat anestesi dan obat darurat digunakan harus secara maksimal. - Perawatan anestesi dimulai sejak pasien berada di atas meja operasi sampai dengan pasien dipindahkan ke ruang pulih sadar. - Sebelum dilakukan tindakan anestesi , dilakukan kembali pemeriksaan nama pasien, data, diagnose dan rencana operasi. - Mengenalkan pasien kepada dokter anestesi, dokter bedah, asisten dan perawat instrument. - Memasang alat pemantau (antara lain tensimeter, ecg, dan alat lainnya sesuai dengan kebutuhan). - Mengatur posisi pasien bersama-sama perawat bedah sesuai dengan posisi yang dibutuhkan untuk tindakan pembedahan. - Selama tindakan anestesi perawat anestesi wajib mencatat semua tindakan anestesi, berespons dan mendokumentasikan semua perubahan fungsi vital tubuh pasien selama anestesi / pembedahan. Pemantauan meliputi system pernapasan, sirkulasi , suhu, keseimbangan cairan, perdarahan, produksi urine dan lain-lain - Perawat anestesi berespons dan melaporkan kepada dokter anestesi bila terdapat tanda-tanda kegawatan fungsi vital tubuh pasien agar dapat dilakukan tindakan segera. - Dokter anestesi melaporkan kepada dokter operator jika terjadi perubahan fungsi vital tubuh pasien dan tindakan yang diberikan selama anestesi.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO	PELAYANAN ANESTESI DI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO		
	No. Dokumen 962.10/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	12. Perawat anestesi mengatur dosis obat anestesi atas pelimpahan wewenang dokter anestesi. 13. Jika terjadi kegawatan pada pasien, maka dokter anestesi bersama tim dapat menanggulangi keadaan gawat darurat. 14. Pada masa pengakhiran anestesi dilakukan pemantauan tanda-tanda vital secara intensif, menjaga jalan nafas supaya tetap bebas, menyiapkan alat-alat dan obat-obatan untuk mengakhiri anestesi dan ekstubasi. Pasca Anastesi / Pembedahan 1. Setelah pengakhiran anestesi, pasien dikirim ke kamar pulih sadar untuk pemantauan fungsi vital tubuh oleh perawat terlatih. 2. Bila dianggap perlu, pasien dapat langsung dikirim ke ruang khusus (misalnya ICU). 3. Memberikan bantuan Oksigenasi, ventilasi dan sirkulasi tetap diberikan. 4. Pemberian analgesic dan sedative disesuaikan dengan kondisi pasien. 5. Keputusan untuk memindahkan pasien dari kamar pulih sadar dibuat oleh dokter anestesi dengan penilaian <i>Score Aldrette</i> dan <i>Bromage</i>.		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. <i>Intensive Care Unit</i> 5. Unit Maternitas 6. Unit Perinatologi 7. IFRS		